

# *Status digestif*

Quatre étapes (poitrine dénudée/ceinture détachée et premier bouton enlevé)

Étapes 1-3 patient couché en décubitus dorsal

Étape 4 patient assis patient couché

- 1. Inspection**
- 2. Auscultation**
- 3. Percussion**
- 4. Palpation**

## **Inspection**

1. Demander au patient si sa vessie vide (nécessaire pour le status)
2. Observer le visage du patient (recherche douleur)
3. Observer la respiration abdominale
4. Observer l'ombilic (cicatrice/caput medusae/vergetures, *grossesse*/hernies)
5. Faire confirmer par le patient l'absence de cicatrices

## **Auscultation**

1. Questionner sur une éventuelle zone de douleur (région abdominale/demander au patient de montrer la région avec le doigt)
2. Ecouter les quatre quadrants abdominaux (division perpendiculaire à l'ombilic) avec le diaphragme en terminant par la région douloureuse
3. Ecouter l'aorte abdominale en plaçant le diaphragme à gauche de la ligne médiane, définie par le processus xyphoïde et l'ombilic

*Ce qui doit être entendu sont des gargouillements au niveau des anses intestinales et du colon/rectum, vérifier le stéthoscope car bruit uniquement en post-pendial (iléus pathologie)*

*Mobilisation des anses par appui du stéthoscope génère un bruit*

## **Percussion**

1. Percuter les quatre quadrants abdominaux en terminant par la région douloureuse (tapoter de manière souple sur deux de ses doigts avec deux autres/ascite)
2. Délimiter le foie par percussion en débutant des poumons vers le bas

*Ce qui doit être entendu est un tympanisme digestif/sonorité poumons/matité foie*

*Foie débute sous le mamelon et se termine légèrement inférieurement à la cage thoracique*

**Palpation superficielle** (se réchauffer les mains)

1. Palpation superficielle à une main des quatre quadrants abdominaux en terminant par la région douloureuse (massage de l'abdomen à la recherche d'une résistance)
2. Rechercher une hernie ombilicale en introduisant son doigt dans l'ombilic et en demandant au patient de relever le buste (contraction du droit de l'abdomen)

**Palpation profonde**

1. Palpation profonde à deux mains des quatre quadrants abdominaux en terminant par la région douloureuse (enfoncer les doigts dans l'abdomen puis détente rapide à la recherche d'une douleur vive à la pression, détente/prévenir patient, désagréable)
2. Palpation profonde spécifique du cadran iliaque droit au niveau de ligne ombilic-épine iliaque supérieure (recherche d'une douleur à la détente, signe appendicite) – confirmer en testant une contraction douloureuse du psoas (flexion de la cuisse contre résistance)
3. Palpation profonde spécifique du foie, en inspiration forcée (enfoncer les doigts sous la cage thoracique, facilité par usage des mains en crochet)
4. Lors de palpation du foie demander au patient de poursuivre son inspiration par une expiration forcée permettant de palper vésicule biliaire (potentielle cholestase, douleur)
5. Palpation profonde spécifique de rate (placer une main sous le patient et enfoncer les doigts sous la cage thoracique, patient relâché/rate palpable uniquement en cas d'hypersplénisme)
6. Palper l'aorte abdominale

**Palpation des reins**

1. Taper du poing sur sa main au niveau des loges rénales, côtes 12 et inférieur (prévenir le patient/recherche d'une douleur, potentielle pyélonéphrite)

**Palpation inguinale** (pas à examen)

1. Prévenir le patient (remonter dans canal inguinal via le scrotum)

**Toucher rectal** (pas à examen)

1. Prévenir le patient